



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ»
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID							
4	2	2	1	1	1	2	9
7							

Прізвище / Surname							
Б	О	К	Л	А	Ц	Ю	К

Варіант / Variant 15

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЄДКІ, ЕТАП 2**

**ІНТЕГРОВАНІЙ ТЕСТОВИЙ ІСПИТ
КРОК 2**

II день

**Спеціальність
«МЕДИЦИНА»**

1. Пацієнт віком 28 років скаржиться на періодичні напади серцебиття. Об'єктивно спостерігається: АТ — 130/80 мм рт. ст., пульс — 65/хв, тони серця не змінені. За результатами ЕКГ виявлено: вкорочення інтервалу Р-Q, поява у складі комплексу QRS додаткової хвилі збудження, деформація комплексу QRS та негативний зубець Р. Який найімовірніший діагноз?

- А. Синдром передчасного збудження шлуночків
- В. Шлуночкова екстрасистолія
- С. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- Д. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- Е. Блокада ніжки пучка Гіса

2. Пацієнт віком 30 років скаржиться на напади вираженого головного болю та стріляючого болю в ділянці обличчя. Із анамнезу відомо, що біль може виникати під час гоління зранку, провокується рухами нижньої щелепи під час їжі, локалізується в ділянці правої щоки, ока, верхньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: різка болючість під час пальпації точки виходу з черепу другої гілки V черепного нерва праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- А. Кластерний головний біль
- В. Головний біль напруги
- С. Невралгія потиличного нерва
- Д. Невралгія трійчастого нерва
- Е. Мігрень

3. Який тип лікарні спеціально організований для забезпечення гуманних, персоніфікованих та сімейно-орієнтованих установ для догляду за невиліковно хворими (паліативними) пацієнтами?

- А. Денний стаціонар
- В. Диспансер
- С. Санаторій
- Д. Багатопрофільна лікарня
- Е. Госпіс

4. Пацієнту віком 16 років проведено ревакцинацію КПК (жір, паротит, краснуха). Через 5 хв після введення вакцини в пацієнта з'явилася задихка, неспокій, пригнічення свідомості, АТ знизився зі 110/70 мм рт. ст. до 60/40 мм рт. ст., з'явилася тахікардія — 130/хв, шкіра та слизові оболонки набули блідо-ціанотичного кольору. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- А. набряк легень
- В. Септичний шок
- С. Непритомність
- Д. Анафілактичний шок
- Е. набряк Квінке

5. Пацієнт віком 28 років скаржиться на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6-ти місяців, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодичний нічний біль. Під час огляду кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гомілці. Який найімовірніший діагноз?

- А. Облітеруючий атеросклероз
- В. Хвороба Такааясу
- С. Емболія стегнової артерії
- Д. Синдром Рейно
- Е. Облітеруючий ендартеріїт

6. Пацієнт віком 65 років скаржиться на персистуючу слабкість, субфебрильну температуру тіла протягом кількох останніх років, підвищену нічну пітливість. Об'єктивно спостерігається: генералізоване збільшення лімфатичних вузлів, спленомегалія. Під час пальпації лімфатичні вузли тістоподібної консистенції, безболісні. Загальний аналіз крові: гемоглобін — 106 г/л, еритроцити — $3,5 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити — $47 \cdot 10^9/л$, еозинофіли — 1%, паличкоядерні нейтрофіли — 8%, сегментоядерні нейтрофіли — 23%, лімфоцити — 68%, моноцити — 0%, тромбоцити — $210 \cdot 10^9/л$, ШОЕ — 50 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий лімфобластний лейкоз
- В. Гострий мієлоїдний лейкоз
- С. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- Д. Множинна мієлома
- Е. Хронічний лімфопролітарний лейкоз

7. У жінки віком 32 роки, у терміні вагітності 39 тижнів, 2 год тому розпочалися перейми частотою 2 за 10 хвилин, тривалістю по 20-30 с. Об'єктивно спостерігається: серцебиття плода звучне, ритмічне — 136/хв, на великих статевих губах та промежині — декілька везикул, схожих на герпетичні. Подібні висипання були і до вагітності 4-5 разів на рік, які пацієнтка пов'язувала із порушеннями гігієни, тому до лікарів не зверталася. Під час піхвового обстеження виявлено: шийка матки згладжена, відкриття на 4 см, плідний міхур цілий, голівка в I площині таза. Яка тактика ведення цієї вагітної?

- А. Кесарів розтин
- В. Пологи вести консервативно, призначити ацикловір
- С. Вкоротити другий період пологів шляхом накладання вакуум-екстрактора
- Д. Пологи вести консервативно, обробити промежину антисептиком
- Е. Пологи вести консервативно

8. Пацієнт віком 35 років на виробництві отримав пошкодження м'яких тканин правого стегна. Об'єктивно спостерігається: на передній поверхні стегна рвана рана розміром 6х5 см, краї рани нерівні, зазубрені, в глибині рани згустки крові, з-під яких продовжується витікання венозної крові. Який найбільш оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі необхідно застосувати в цьому разі?

- А. Накладання тугої тиснучої пов'язки
- В. Підвищене положення кінцівки
- С. Накладання джгута проксимальніше рани
- Д. Накладання джгута дистальніше рани
- Е. Пальцеве притискання

9. Шестирічна дитина скаржиться на головний біль, слабкість, біль під час жування. Об'єктивно виявлено: двобічне збільшення слинних залоз, що заповнюють ретромандибулярну ямку, шкіра над залозами напружена, блискуча, колір її не змінений. Температура тіла — 39°C . На слизовій оболонці ротової порожнини спостерігаються сухість, набряклість зовнішнього отвору протоку слинної залози. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфекційний мононуклеоз
- B. Слипокам'яна хвороба
- C. Пухлини слинних залоз
- D. Епідемічний паротит
- E. Дифтерія

10. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на безпліддя впродовж 3-х років. В анамнезі: гонорея. Об'єктивно спостерігається: розвиток статевих органів без відхилень від норми. Базальна температура протягом трьох циклів двофазна. Яка найімовірніша причина безпліддя?

- A. Ендокринний чинник
- B. Аномалія будови статевих органів
- C. Ендоменстріоз
- D. Порушення прохідності маткових труб
- E. Імунологічне безпліддя

11. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль унизу живота та незначні мажучі кров'яністі виділення зі статевих шляхів упродовж 3-х годин. Із анамнезу відомо, що остання менструація — 2 місяці тому. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця, виділення геморагічні незначні. За результатами УЗД спостерігається: порожнина матки розширена — картина «снігової віхри». Який найімовірніший діагноз?

- A. Загроза мимовільного викидня
- B. Ендоменстріоз
- C. Апоплексія яєчника
- D. Викидень у ході
- E. Пухирний занос

12. Восьмирічна дівчинка скаржиться на слабкість, кашель, головний біль, сльозотечу, появу висипу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — $39,2^{\circ}\text{C}$, кон'юнктивіт, нежить, яскрава гіперемія задньої стінки глотки, на слизовій оболонці під — дрібний поодинокий висип білуватого кольору, на обличчі, шиї та грудях — макулопапулезний висип. Який найімовірніший діагноз?

- A. Краснуха
- B. Інфекційний мононуклеоз
- C. Менінгококцемія
- D. Скарлатина
- E. Кіп

13. Десятирічний хлопчик скаржиться на м'язовий біль, утруднення під час підйому сходами та одягання. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 4 місяці тому, але останнім

часом відзначається посилення болю у м'язах, зниження апетиту, утруднення ковтання. Об'єктивно спостерігається: набряклість обличчя, лілова періорбітальна еритема та десквамація шкіри рук і тулуба. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматоміозит
- B. Ювенільний ревматоїдний артрит
- C. Системна склеродермія
- D. Системний червоний вовчак
- E. Гостра ревматична гарячка

14. Пацієнт віком 25 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, появу висипання. Із анамнезу відомо, що 3 тижні тому хворів на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: петехіальний висип на симетричних ділянках тіла, переважно на ногах та сідницях, температура тіла — $37,4^{\circ}\text{C}$, АТ — 110/80 мм рт. ст. За результатами загального аналізу крові виявлено: еритроцити — $3,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін — 110 г/л, колірний показник — 0,9, тромбоцити — $160 \cdot 10^9/\text{л}$, лейкоцити — $8,7 \cdot 10^9/\text{л}$, еозинофіли — 4%, базофіли — 0%, паличкоядерні нейтрофіли — 7%, сегментоядерні нейтрофіли — 56%, лімфоцити — 26%, моноцити — 7%, ШОЕ — 17 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гемофілія А
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Гострий лімфобластний лейкоз
- D. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- E. Авітаміноз С

15. Пацієнтку віком 27 років шпиталізовано до лікарні з ознаками маткової кровотечі. Із анамнезу відомо, що протягом останніх днів вона відчувала тягучий біль у нижніх відділах живота, але до лікаря не зверталася. Пацієнтка спостерігалася в жіночій консультації з приводу вагітності (11-12 тижнів). За результатами гінекологічного обстеження виявлено: піхва заповнена згустками крові, шийка матки розкрита на 2 см, в каналі визначається напружений плодовий міхур, матка збільшена до розмірів 11-12 тижнів вагітності, напружена, виділення геморагічні, дуже рясні. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнтці в цьому разі?

- A. Накладання пива на шийку матки
- B. Внутрішньовенне введення дексаметазону
- C. Вишкрібання стінок порожнини матки
- D. Проведення токолітичної терапії
- E. —

16. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль та набряклість колінних суглобів, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, слабкість. Із анамнезу відомо, що 3 тижні тому хворіла на скарлатину. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, колінні суглоби набрякли, рухи в них болючі, обмежені. Перкуторно: межі серця змщені ліворуч на 1,5 см. Аускультативно: тони серця ослаблені, аритмія, систолічний шум на верхівці. В аналізі крові: ШОЕ — 48 мм/год, АСЛ-О — 413 Од/мл. Який найімовірніший діагноз?

- A. Реактивний артрит
- B. Дерматоміозит
- C. Гостра ревматична гарячка
- D. Міокардит
- E. Ювенільний ревматоїдний артрит

17. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль дифузного характеру, незначне запаморочення, нудоту та складність фокусування погляду. Із анамнезу відомо, що 4 год тому отримав травму у ділянці голови. Результати неврологічного огляду: черепні нерви без патології, сухожилкові рефлексі S=D, позитивний субкортикальний рефлекс Марінеско-Родовічі, моторна та чутлива сфера без патології, позитивний симптом Гуревича-Мана, в позі Ромберга — легке похитування. Свідомість ясна. За результатами комп'ютерної томографії головного мозку: без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Забій головного мозку середнього ступеня
- B. Струс головного мозку
- C. Субарахноїдальний кроволив
- D. Дифузне аксональне пошкодження
- E. Забій головного мозку легкого ступеня

18. У п'ятирічної дитини через 2 тижні після перенесеної краснухи з'явилися носові кровотечі, петехіальний висип на шкірі та слизових оболонках різної форми та кольору, що зникає під час натискування. В аналізі крові: тромбоцити — $50 \cdot 10^9/\text{л}$. Який найімовірніший діагноз?

- A. Системний червоний вовчак
- B. Тромбоцитопенічна пурпура
- C. Геморагічний васкуліт
- D. Гемофілія
- E. ДВЗ-синдром

19. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на спрагу (випиває 8-10 л води за добу), поліурію, головний біль і загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що переніс черепно-мозкову травму. Під час обстеження патології внутрішніх органів не виявлено. За результатами аналізу крові виявлено: глюкоза — $4,5 \text{ ммоль/л}$, Na^+ — 159 ммоль/л , осмолярність плазми крові — 305 мосм/л . У загальному аналізі сечі спостерігається: питома вага — 1,001-1,004, білок, лейкоцити — 2-3 в полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первинний гіперальдостеронізм
- B. Гострий гломерулонефрит
- C. Феохромоцитома
- D. Нечукровий діабет
- E. Цукровий діабет

20. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу різкого болю в правій здухвинній ділянці, затримку менструації на 5 тижнів. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки бліді, пульс — 104/хв, АТ — 80/60 мм рт. ст., симптоми подразнення очеревини різко позитивні. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: слизова оболонка піхви та шийки матки ціанотична, зов-

ніший зів закритий, задне склепіння навісає. Симптом Промптова різко позитивний. Під час пункції черевної порожнини через задне склепіння піхви отримано рідку кров, що не згортається. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рак сідометрія
- B. Порушена позаматкова вагітність праворуч
- C. Перекрут ніжки пухлини яєчника
- D. Апоплексія правого яєчника
- E. Загострення хронічного аднекситу

21. Пацієнту віком 28 років із гострою шлунково-кишковою кровотечею III ступеня перелито 1000 мл одноступенної консервованої еритроцитарної маси. Укажіть препарат, який необхідно застосувати під час гемотрансфузії для профілактики цитратної інтоксикації.

- A. Калію глюконат
- B. Літію хлорид
- C. Кальцію хлорид
- D. Натрію хлорид
- E. Магнію сульфат

22. Пацієнт віком 45 років скаржиться на порушення мовлення та ковтання, опущення повік, стало складно тримати голову. Із анамнезу відомо, що стан погіршується протягом доби, під вечір. В неврологічному статусі: голова звисає на груди, мовлення гугняве, захлинається під час ковтання, слабкість м'язів з обох боків, парез м'якого піднебіння. Рефлексі з м'якого піднебіння та глотковий збережені. Язик — по середній лінії, не змінений. Сухожилкові рефлексі жваві, рівномірні. Парезів кінцівок не виявлено. Вранці раптово стан погіршився: виражена дизартрія, не ковтає, дихання утруднене, з'явився ціаноз губ. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A. Міастенічний криз
- B. Холінергічний криз
- C. Аддісонічний криз
- D. набряк легень
- E. Епілептичний напад

23. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на схуднення, біль у нижній частині живота, випорожнення з домішками слизу та крові до 12-ти разів на добу. Під час фіброколоноскопії виявлено: у ділянці сигмовидної кишки візуалізуються локальні псевдополіпозні розростання, плоскі поверхневі виразкові ділянки неправильної форми, що не зливаються, вкриті слизом та фібрином, контактна кровоточивість. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Гіршпрунга
- B. Черевний тиф
- C. Псевдомембранозний коліт
- D. Виразковий коліт
- E. Хвороба Крона

24. У пацієнта під час клінічного обстеження в сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей фосфорної кислоти. Його раціон хар-

чування містить житній та пшеничний хліб, макаронні вироби, вершкове масло, олію, картопляне пюре, молоко, сир, каву, чай, відвар шипшини, кисіль зі смородини. Енергоцінність раціону відповідає енерговитратам. Які продукти потрібно обмежити в раціоні пацієнта?

- A. Відвар шипшини і кисіль
- B. Макаронні вироби і хліб
- C. Кисіль зі смородини
- D. Молоко і сир
- E. Каву та чай

25. Пацієнт віком 28 років під час фізичних вправ знемає відчув слабкість, біль у правій половині грудей з іррадіацією в праве плече, задню, прискорене серцебиття. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, тахікардія до 100/хв, ЧД — 28/хв, температура тіла — 36,6°C, права половина грудної клітини відстає в акті дихання. Перкуторно з правого боку високий тимпанічний звук над легеньми, дихальні шуми не прослуховуються. Який найімовірніший діагноз?

- A. Емпієма плевральної порожнини
- B. Медіастиніт
- C. Абсцес легені
- D. Спонтанний пневмоторакс
- E. Інфаркт міокарда

26. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано до лікарні після нападу сильного болю в животі, який виник раптово після незначного фізичного навантаження. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка нерухомо лежить на боках, неохоче спілкується, оскільки під час розмови виникає посилення болю. Під час пальпації визначається напружений живіт та позитивні симптоми подразнення очеревини в усіх відділах живота. За результатами рентгенографії ОЧП: наявне повітря під куполом діафрагми. Який найімовірніший діагноз?

- A. Апендикулярний абсцес
- B. Защемлення внутрішньої грижі живота
- C. Туберкульозний перитоніт
- D. Гостра кишкова непрохідність
- E. Перфоративна виразка шлунка або дванадцятипалої кишки

27. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на надмірні виділення з піхви. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: слизова оболонка шийки матки та стінок піхви звичайного рожевого кольору, виділення слизово-водянисті із «рибним запахом», тіло матки і додатки не змінені. Під час бактеріоскопічного дослідження мазків, забарвлених за Грамом, виявлено ключові клітини. Який найімовірніший діагноз?

- A. Трихомоніаз
- B. Бактеріальний вагіноз
- C. Хламідіоз
- D. Герпетична інфекція
- E. Гонорея

28. Для перевірки гіпотензивного ефекту лікарського засобу відібрано 100 людей з артеріальною гіпертензією, яким призначили прийом цього препарату. Для оцінки статистичної значущості результатів буде порівняно значення систолічного артеріального тиску до початку лікування та через тиждень після початку. Який статистичний метод потрібно використати за умови розподілу значень артеріального тиску, відмінного від нормального?

- A. Т-критерій Вілкоксона
- B. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок
- C. —
- D. U-критерій Манна-Уїтні
- E. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок

29. У дворічної дитини спостерігається значне погіршення самопочуття, різке зниження апетиту, поява нудоти та блювання без видимих причин, блідість шкірних покривів, млявість, пітливість. За результатами рентгенографії органів грудної клітки виявлено: пухлиноподібне утворення у верхніх відділах заднього середостіння з правого боку, що прилягає широкою основою до тіні хребта. Дослідження сечі на катехоламіни: збільшення незрілих фракцій катехоламінів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лімфома
- B. Бронхіальна кіста
- C. Тимома
- D. Нейробластома
- E. Карцинома

30. Пацієнт віком 68 років, що лікувався в стаціонарі з приводу нестабільної стенокардії, під час ходіння раптово втратив свідомість, упав. Об'єктивно спостерігається: пульсація на артеріях відсутня, зіниці вузькі, на світло не реагують, рідкі малоамплітудні рухи грудної клітки — до 8-10/хв, АТ не визначається. На ЕКГ виявлено: синусоїдна крива з частими, різними за формою і амплітудою хвилями частотою 350-400/хв. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Фібриляція шлуночків
- B. Асистолія
- C. Фібриляція передсердь
- D. Повна атріовентрикулярна блокада
- E. Тромбоемболія легеневої артерії

31. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на нестерпний свербіж шкіри, тупий біль у ділянці правого підребер'я, загальну слабкість, стомлюваність, втрату апетиту. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом останніх 3-х років, коли вперше з'явився періодичний шкірний свербіж. Об'єктивно спостерігається: шкіра темно-коричневого кольору з ділянками екскоріації, ксантеласми на повіках, незначна гепатомегалія, спленомегалія. В аналізі крові: загальний білірубін — 68 мкмоль/л, прямий — 36 мкмоль/л, холестерин — 8,2 ммоль/л, збільшений рівень лужної фосфатази та γ -глутамілтрансферази.

Імунологічне дослідження крові: наявність антимітохондріальних антитіл (АМА) у титрі 1:160. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гемохроматоз
- В. Хвороба Іценко-Кушинга
- С. Вірусний гепатит С
- Д. Первинний біліарний цироз
- Е. Хвороба Вільсона

32. У породіллі спостерігається масивна кровотеча після народження дитини через природні пологові шляхи. Дитяче місце та родові шляхи цілі. Дно матки — вище пупка, матка під час пальпації м'яка, не реагує на введення утеротоніків. Яка найімовірніша причина кровотечі?

- А. Атонія матки
- В. Затримка частки плаценти
- С. Пошкодження шийки матки
- Д. Розрив матки
- Е. Гіпотонія матки

33. Пацієнт віком 26 років скаржиться на набряк повік, утруднене дихання. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 3-й день після початку прийому антибіотиків, хворіє на поліноз. Об'єктивно спостерігається: гіперемія червоної облямівки губ, гіперемія та набряк повік, м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів. Аускультативно: везикулярне дихання. Який найімовірніший діагноз?

- А. Інфекційний мононуклеоз
- В. Бронхіальна астма
- С. Кропив'янка
- Д. Гострий герпетичний хейліт
- Е. Набряк Квінке

34. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на безсоння, занепокоєння, не може пити воду через виражені болючі спазми гортані. З епіданамнезу відомо, що пацієнтку вкусила за гомілку бродяча кішка. Який найімовірніший діагноз?

- А. Енцефаліт
- В. Менінгіт
- С. Бартофельоз
- Д. Сказ
- Е. Пращець

35. У новонародженого хлопчика, що народився від другої доношеної вагітності з масою тіла 3400 г, на 4-ту годину життя з'явилося іктеричне забарвлення слизових оболонок та шкіри, що швидко поширилося на тулуб та кінцівки. Об'єктивно спостерігається: дитина млява, тонус м'язів знижений, рефлекс пригнічені, відмовляється від грудей, печінка та селезінка незначно збільшені, сеча та випорожнення звичайного кольору. З анамнезу відомо, що у матері А (II) Rh (-) група крові, у батька А (II) Rh (+). Рівень білірубину в пуповинній крові у дитини в першу добу життя — 88 мкмоль/л за рахунок непрямого. Пряма проба Кумбса позитивна. Загальний аналіз крові та мазок крові без особливостей. Який найімовірніший діа-

гноз?

- А. Геморагічна хвороба новонародженого
- В. Гемолітична хвороба новонародженого за системою АВО
- С. Гемолітична хвороба новонародженого за Rh-фактором
- Д. Фізіологічна жовтяниця новонародженого
- Е. Вроджений гепатит

36. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C, озноб, кашель із мокротинням, кровохаркання та біль у грудній клітці під час дихання, міалгію, діарею. З анамнезу відомо, що працює у фірмі обслуговування кондиціонерів. Де кілька днів тому його колега звернувся до лікарні з такими самими скаргами. Під час рентгенографії ОГК виявлено: вогнищеві інфільтративні тіні різної форми та щільності в обох легенях. Який збудник, найімовірніше, викликав захворювання?

- А. Стафілокок
- В. Пневмокок
- С. Мікоплазма
- Д. Клебсієла
- Е. Леґіонела

37. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль, обмеження рухів у дрібних суглобах кистей, утруднене ковтання твердої їжі, загальну слабкість, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей, передпліч, обличчя щільна, гладенька, проксимальні суглоби II-IV пальців кистей набряклі, болючі під час пальпації. Аускультативно: над легеньми сухі розсіяні хрипи, межі серця зміщені ліворуч на 2 см, тони дещо ослаблені. В аналізі крові: ШОЕ — 38 мм/год, γ -глобуліни — 25%, СРБ — ++. Який найімовірніший діагноз?

- А. Дерматоміозит
- В. Саркоїдоз
- С. Ревматоїдний артрит
- Д. Системна склеродермія
- Е. Системний червоний вовчак

38. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, головний біль у лобній ділянці, біль в очах, світлочутливість, біль у м'язах, сухий кашель. Із анамнезу відомо, що захворіла гостро напередодні. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, обличчя гіперемоване, очі блискучі, ін'єкція склер. Пульс — 96/хв, ритмічний. Тони серця приглушені. У легенях розсіяні сухі хрипи. Слизова оболонка ротоглотки гіперемована, зерниста, судини розширені. Менінгеальних симптомів немає. За результатами загального аналізу крові виявлено: лейкоцити — $3 \cdot 10^9$ /л, еозинофіли — 1%, паличкоядерні нейтрофіли — 6%, сегментоядерні нейтрофіли — 51%, лімфоцити — 35%, моноцити — 7%. Який найімовірніший діагноз?

- A. Кір
- B. Висипний тиф
- C. Грип
- D. Менінгококова інфекція
- E. Пневмонія

39. Пацієнта віком 37 років госпіталізовано в неприємному стані. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет 1-го типу протягом 10-ти років, отримує 56 ОД інсуліну на добу у двох ін'єкціях. Стан раптово погіршився вдома, з'явилася різка слабкість, пітливість, тремтіння, невиразне мовлення. Об'єктивно спостерігається: АТ — 140/90 мм рт. ст., ЧСС — 100/хв, мимовільне сечовипускання. Аускультативно: над легенями вислуховується везикулярне дихання. Який лікарський засіб необхідно ввести першочергово пацієнту в цьому разі?

- A. Розчин NaCl 0,9% 400,0 мл в/в крапельно
- B. Розчин глюкози 40%-ий 20-40 мл в/в
- C. Пролонгований інсулін 20 ОД підшкірно
- D. Інсулін короткої дії 0,1-0,2 ОД/кг в/в
- E. Розчин глюкози 5%-ий 400,0 мл в/в крапельно

40. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на появу висипу, що супроводжується незначним свербіжем. Під час огляду на шкірі волосистої частини голови виявлено папули рожево-червоного кольору, округлої форми, схильні до злиття, вкриті сріблястими лусочками. Із анамнезу відомо, що висип з'явився після перенесеного стресу. У батька пацієнта періодично спостерігаються аналогічні висипання. Який найімовірніший діагноз?

- A. Атопічний дерматит
- B. Мікроспорія волосистої частини голови
- C. Різнокольоровий лишай
- D. Себорейна екзема
- E. Псоріаз

41. Пацієнт віком 19 років скаржиться на біль в епігастрії, нудоту, сеча набула темно-коричневого кольору. Із анамнезу відомо, що протягом 4-х днів його турбували загальна слабкість, утруднення носового дихання та підвищена температура тіла до 37,4°C. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вірусний гепатит А
- B. Вірусний гепатит В
- C. Інфекційний мононуклеоз
- D. Лептоспіроз
- E. Виразкова хвороба

42. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на запаморочення, відчуття прискореного серцебиття, задишку під час помірного фізичного навантаження. Із анамнезу відомо, що скарги турбують останні 6 місяців із поступовим погіршенням. Спостерігається у лікаря-гінеколога з приводу менорагій. Об'єктивно спостерігається: ЧД — 20/хв, ЧСС — 94/хв, шкіра та склери бліді. В аналізі крові: гемоглобін — 92 г/л, еритроцити — $3,9 \cdot 10^{12}/л$, КР — 0,71, середній об'єм еритроцита — 70 фл, середній вміст гемоглобіну в еритроциті — 26 пг, тромбоцити —

$240 \cdot 10^9/л$, лейкоцити — $6,8 \cdot 10^9/л$, паличкоядерні — 3%, соєинофіли — 0%, базофіли — 1%, сегментоядерні — 59%, моноцити — 6%, лімфоцити — 31%, ШОЕ — 38 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гемолітична анемія
- B. Залізодефіцитна анемія
- C. Гостра постгеморагічна анемія
- D. Апластична анемія
- E. В₁₂-дефіцитна анемія

43. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на різкий біль у ділянці відхідника, виділення крові з прямої кишки після акту дефекації протягом 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: у ділянці відхідника наявне випинання ціанотичного кольору розміром до 3x4x3 см, контактно — помірна кровоточивість, під час пальпації — болючість і напруження утворення. Який найімовірніший діагноз?

- A. Поліп анального каналу
- B. Гостра анальна тріщина
- C. Випадіння прямої кишки
- D. Гострий тромбоз гемороїдального вузла
- E. Рак прямої кишки

44. Пацієнта віком 42 роки госпіталізовано до травматологічного відділення. Рентгенологічно виявлено перелом кісток таза. Об'єктивно спостерігається: самостійне сечовиділення відсутнє, уретрорагія. Пальпуються збільшений сечовий міхур і болісна припухлість у ділянці промежини. Який попередній діагноз?

- A. Забій промежини
- B. Травма сечового міхура
- C. Травма уретри
- D. Гостра ниркова недостатність
- E. Рефлекторна затримка сечовипускання

45. Під час огляду дитини на 4-ту добу життя в ділянці шиї, потилиці й сідниць з'явилися пухирці з серозно-гнійним вмістом. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний, дитина активна, рефлекси новонароджених викликаються в повному обсязі, пуповина на стадії муміфікації, пупочна ділянка без особливостей. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бульозний епідермоліз
- B. Пухирчатка новонароджених
- C. Флегмона
- D. Пітниця
- E. Везикулопустульоз

46. Пацієнт віком 74 роки скаржиться на загальну слабкість, іктеричність шкіри та склер, дискомфорт у правій підреберній ділянці, схуднення на 10 кг за останні 2 місяці. Об'єктивно спостерігається: пульс — 76/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Під час пальпації живіт м'який, децю чутливий у правій підреберній ділянці, де пальпується, значно збільшений, напружений та безболісний жовчний міхур. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рак голівки підшлункової залози
- B. Гострий холецистит
- C. Хвороба Крона
- D. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки
- E. Жовчнокам'яна хвороба

47. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на порушення менструального циклу, рясні менструації протягом останнього року. Із анамнезу відомо: 1 пологи, 2 штучних абортів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: зовнішні статеві органи розвинені правильно. Шийка матки циліндричної форми, макроскопічно не змінена. Тіло матки збільшене до 9-10 тижнів вагітності, щільне, з горбистою поверхнею, рухоме, безболісне. Придатки з обох боків без особливостей. Виділення слизові, помірні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Внутрішній ендометріоз
- B. Лейоміома матки
- C. Рак тіла матки
- D. Гострий ендометрит
- E. Маткова вагітність

48. У загальноосвітньому навчальному закладі проводиться медичний огляд школярів. Вирішується питання щодо вибору методу оцінки фізичного розвитку учнів. Які переваги має метод оцінки за шкалами регресії у порівнянні з методом сигмальних відхилень?

- A. Враховується кореляційна залежність між ростом, масою тіла та окружністю грудної клітки
- B. Метод наочний і не потребує розрахунків
- C. Надає можливість оцінки біологічного і хронометражного віку та їх відповідності
- D. Кожен соматометричний показник оцінюється відокремлено і можна побудувати профіль фізичного розвитку
- E. Можна оцінити пропорційність фізичного розвитку

49. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після 4-х років менопаузи. Під час бімануального дослідження виявлено: шийка матки циліндричної форми, епітелій цілий. Матка в антефлексію, дещо збільшена в розмірах, рухома. Додатки матки не пальпуються, виділення геморагічні. Під час діагностичного вишкрібання порожнини матки отримано мозкоподібний зішкріб. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дисфункціональна маткова кровотеча
- B. Аденоміоз матки
- C. Клімактерична кровотеча
- D. Рак тіла матки
- E. Лейоміома матки

50. У пацієнтки віком 69 років через 2 тижні після перенесеної операції на органах черевної порожнини з'явився біль униз живота і в правому стегні, підвищилася температура тіла до 38,2°C. Через добу в пацієнтки з'явився набряк правого стегна, а потім — і всієї нижньої кінцівки. Об'єктивно спостерігається:

права нижня кінцівка ціанотична, пульсація на артеріях кінцівки виявляється, стегно під час пальпації болюче, рух у кінцівці обмежений, живіт м'який, болючий у правій клубовій ділянці праворуч. Синдромів подразнення очеревини немає. Яке ускладнення виникло в пацієнтки в післяопераційному періоді?

- A. Гострий мезентеріальний тромбоз
- B. Гострий клубово-стегновий венозний тромбоз
- C. Синдром Леріша
- D. Гострий тромбоз нижньої порожнистої вени
- E. Гостра емболія загальної клубової артерії

51. У пацієнта віком 72 роки на 6-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. Об'єктивно спостерігається: верхня половина тулуба, шия та обличчя ціанотичні, кашель, різкий біль за грудниною, АТ — 90/60 мм рт. ст., ЧСС — 130/хв, ЧД — 32/хв. На ЕКГ: інверсія зубця Т. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Пневмонія
- C. Септичний шок
- D. Тромбоемболія легеневої артерії
- E. Гіповолемічний шок

52. За результатами лабораторного дослідження ґрунту виявлено: санітарне число Хлебнікова — 0,98, титр БГКП — 1,0, титр анаеробів — 0,1, яєць гельмінтів немає, личинок та лялечок мух немає. Оцініть рівень забруднення ґрунту.

- A. Відносно забруднений
- B. Чистий
- C. Сильно забруднений
- D. Слабко забруднений
- E. Забруднений

53. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, свербіж, підвищення температури тіла до 37,5°C, біль у лівому та правому підбер'ї, збільшення лімфатичних вузлів. За результатами загального аналізу крові спостерігається: нейтрофільний лейкоцитоз, лімфоцитопенія, анемія, збільшена ШОЕ. Під час біопсії лімфатичного вузла виявлено: поліморфноклітинні гранулеми та клітини Березовського-Штернберга. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- B. Лімфогранулематоз
- C. Множинна мієлома
- D. Хронічний лімфоцитарний лейкоз
- E. Гострий лімфобластний лейкоз

54. У пацієнта виявлено енцефалопатію, поліневропатію, порушення порфіринового обміну. У загальному аналізі крові спостерігається: базофільна зернистість еритроцитів. Функція нирок та печінки порушена. Отруєння яким металом спричинило таку клінічну симптоматику?

- A. Марганцем
- B. Кадмієм
- C. Сріблом
- D. Ртуттю
- E. Свинцем

55. Під час поточного санітарного обстеження терапевтичного відділення лікарні проведено визначення показників мікроклімату у палатах. Результати вимірювань: середня температура повітря — 20°C , перепад температури по вертикалі — 2°C , по горизонталі — 1°C , швидкість руху повітря — $0,15\text{ м/с}$, відносна вологість повітря — 55%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палат.

- A. Дискомфортний із підвищеною вологістю повітря
- B. Дискомфортний охолоджувального типу
- C. Комфортний
- D. Дискомфортний із підвищеною швидкістю руху повітря
- E. Дискомфортний нагрівного типу

56. Чотиримісячну дитину госпіталізовано зі встановленим діагнозом: стафілококова пневмонія. Із анамнезу відомо, що в дитини протягом 2-х днів немає випорожнень, гази не відходять, декілька разів було блювання пилунковим вмістом, з домішкою жовчі. Об'єктивно спостерігається: живіт здутий, м'який, перистальтика не вислуховується. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини: рівномірно роздуті газом петлі кишечника, множинні чаші Клойбера невеликого діаметру. Який найімовірніший діагноз?

- A. Паралітична кишкова непрохідність
- B. Обтураційна кишкова непрохідність
- C. Странгуляційна кишкова непрохідність
- D. Перфоративний перитоніт
- E. Кишкова інвагінація

57. Батьки хлопчика (вік — 1 рік 7 місяців) скаржаться на підвищення температури тіла в дитини до $39,2^{\circ}\text{C}$, відмову від їжі, але не від пиття. Із анамнезу відомо, що дитина була цілком здорова та не хворіла до цього часу. Об'єктивно спостерігається: гіперемія слизової оболонки ротоглотки, множинні везикули та дрібні (до 2 мм) ерозії на слизовій оболонці піднебінних мигдаликів, м'якого піднебіння та язичка. Інших патологічних змін не знайдено. Який збудник, найімовірніше, викликав інфекцію в дитини?

- A. Вірус простого герпесу
- B. Вірус Епштейна-Барр
- C. Аденовірус
- D. Вірус грипу
- E. Вірус Коксаки

58. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$, біль унизу живота, дизуричні розлади. Із анамнезу відомо, що 3 доби тому був штучний аборт. За результатами бімануального дослідження виявлено: шийка матки циліндрична, вічко закрите, тіло матки дещо збільшене,

болюче, м'яке. Придатки матки не пальпуються. Виділення гнійно-геморагічні. В аналізі крові: лейкоцити — $10 \cdot 10^9/\text{л}$, паличкоядерні нейтрофіли — 12%. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий ендометрит
- B. Гострий сальпінгоофорит
- C. Пельвіоперитоніт
- D. Ендометріоз
- E. Гострий цистит

59. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж шкіри, що посилюється ввечері. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 1,5 місяця. Об'єктивно спостерігається: на шкірі міжпальцевих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях візуалізується висип, що складається з парних папул, покритих кров'янистими кірочками, лінійні розчухи. Який найімовірніший діагноз?

- A. Істинна екзема
- B. Псоріаз
- C. Кропив'янка
- D. Контактний дерматит
- E. Короста

60. У пацієнта віком 29 років ввечері раптово з'явився ниючий біль постійного характеру в епігастральній ділянці. За дві години виникла нудота, було одноразове блювання. До ранку біль став різким і перемістився в праву клубову ділянку. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — $37,6^{\circ}\text{C}$, ЧСС — 90/хв. Під час пальпації виявлено: болючість та напруження м'язів передньої черевної стінки в правій клубовій ділянці, позитивний симптом Воскресенського. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гостра кишкова непрохідність
- B. Гострий апендицит
- C. Гострий панкреатит
- D. Перфоративна виразка пилунка
- E. Жовчокам'яна хвороба

61. Пацієнт віком 48 років скаржиться на тупий біль у ділянці правого підребер'я, слабкість, втрату апетиту, гіркоту в роті. Із анамнезу відомо, що він довгий час зловживав алкоголем. Об'єктивно спостерігається: іктеричність шкіри та склер, судинні зірочки на передній поверхні грудної клітки, розширені вени передньої черевної стінки. Під час пальпації живіт здутий, вільна рідина в черевній порожнині, печінка на 5 см виступає з-під краю реберної дуги, ущільнена, безболісна. Пальпується край селезінки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вітамін B_{12} -дефіцитна анемія
- B. Хронічний холецистит
- C. Пухлина головки підшлункової залози
- D. Хронічний гепатит В
- E. Цироз печінки

62. У пацієнтки віком 47 років, дизайнера за фахом, з'явилися скарги на серцебиття, пітливість, тремор рук, біль в очах. Із анам-

пезу відомо, що протягом 7-ми місяців приймає аміодарон, варфарин, лізіноприл, торасемід та триметазидин з приводу персистоючої форми фібриляції передсердь. Який лікарський засіб, найімовірніше, призвів до погіршення стану пацієнтки?

- А. Аміодарон
- В. Торасемід
- С. Варфарин
- Д. Триметазидин
- Е. Лізіноприл

63. Пацієнт віком 58 років скаржиться на запаморочення та кволість, схуд на 14 кг протягом 2-х місяців. В анамнезі зазначено: перенесений туберкульоз. Об'єктивно спостерігається: посилена пігментація шкіри, дефіцит маси тіла — 10 кг, АТ — 90/55 мм рт. ст. За результатами аналізу крові виявлено: Na^+ — 117 ммоль/л, K^+ — 6,4 ммоль/л, Cl^- — 116 ммоль/л, $[HCO_3^-]$ — 27 мекв/л, глюкоза — 2,9 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічна ниркова недостатність
- В. Хронічний гломерулонефрит
- С. Надниркова недостатність
- Д. Тромбоз ниркових вен
- Е. Синдром Гудпасчера

64. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках, що виникла вранці та поступово наросла протягом дня. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, АТ — 190/100 мм рт. ст., ЧСС — 80/хв, пульс ритмічний, систолічний шум на шії в проекції біфуркації правої загальної сонної артерії. Під час дослідження неврологічного статусу встановлено: згладженість носогубної складки ліворуч, девіація язика вліво, зниження м'язової сили в лівих кінцівках до 3 балів, сухожилкові рефлекси S>D, позитивний симптом Бабінського з лівого боку, лівобічна гемігіпестезія. Який найімовірніший діагноз?

- А. Розсіяний склероз
- В. Інфаркт мозку
- С. Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія
- Д. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
- Е. Субарахноїдальний крововилив

65. На працівників під час виконання робіт у гірничих виробках діє мінеральний пил у вигляді аерозолів дезінтеграції. Для визначення рівня небезпеки виникнення професійних пилових захворювань вивчали хімічні та фізичні властивості пилу. Яка із властивостей пилу визначає загалом глибину його проникнення в дихальні шляхи?

- А. Розчинність
- В. Форма пилових часток
- С. Вміст діоксиду кремнію
- Д. Дисперсність
- Е. Електрозарядженість

66. Під час дослідження якості рибних консервів виявлено здуття кришок. Після на-

тискання кришка повільно повертається у вихідне положення. Деформація стінок банок відсутня. На їхній внутрішній поверхні — темні плями. Який вид бомбажу можна констатувати?

- А. Фізичний
- В. Механічний
- С. Хімічний
- Д. Мікробіологічний
- Е. Справжній

67. Жінка віком 34 роки, з терміном вагітності 38 тижнів, скаржиться на різкий біль у животі, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. В анамнезі: помірна преєклампсія. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс — 120/хв, АТ — 90/60 мм рт. ст. Під час пальпації матка напружена, болюча. Серцебиття плода відсутнє. Який найімовірніший діагноз?

- А. Передчасне відшарування плаценти
- В. Передлежання плаценти
- С. Клінічно вузький таз
- Д. Дискоординована пологова діяльність
- Е. Еклампсія

68. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до лікарні в тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: у свідомості, шкіра бліда, холодна, вкрита липким потом, риси обличчя загострені, темні кола навколо очей, генералізовані тоніко-клонічні судоми, температура тіла — 35,5°C, пульс — 150/хв, АТ — 40/0 мм рт. ст., язик сухий. Під час пальпації живіт безболісний. Випорожнення мимовільні, водянисті, тричі було блювання «фонтаном». Який найімовірніший діагноз?

- А. Гіповолемічний шок
- В. Анафілактичний шок
- С. Колапс
- Д. набряк головного мозку
- Е. Септичний шок

69. Пацієнт віком 66 років скаржиться на різкий біль за грудниною, одноразове блювання, задишку, підвищення температури тіла до 39°C. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому проковтнув фрагмент качиної кістки, зловживав алкоголем. В аналізі крові: лейкоцити — $16 \cdot 10^9/\text{л}$, зсув лейкоцитарної формули вліво. За результатами рентгенографії ОГК: базальний пневмофіброз, контур середостіння не чіткий. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнта?

- А. Аневризма аорти
- В. Гострий панкреатит
- С. Абсцес легень
- Д. Медіастиніт
- Е. Перикардит

70. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на запаморочення, задишку під час незначного фізичного навантаження, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,4°C. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому вона перехворіла на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, ЧД — 26/хв, пульс

— 85/хв, слабкого наповнення, АТ — 100/50 мм рт. ст. Перкуторно — межі серця розширені ліворуч і праворуч. Аускультативно: тони серця глухі, у легенях вислуховується везикулярне дихання, ослаблене в нижніх відділах. Набряків немає. Пальпується збільшена на 2 см печінка. На ЕКГ: ритм синусовий, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий перикардит
- B. Пневмонія
- C. Інфаркт міокарда
- D. Гострий міокардит
- E. Септичний ендокардит

71. Восьмирічній дівчинці встановлено діагноз: гострий лімфобластний лейкоз. Відповідно до протоколу лікування введено циклофосфамід. Наступного дня в неї виникло блювання, що не припинялося протягом 4-х год. Який лікарський засіб необхідно призначити дівчинці для припинення блювання в цьому разі?

- A. Аскорбінову кислоту
- B. Дрогверин
- C. Ондасетрон
- D. Налоксон
- E. Фолієву кислоту

72. У п'ятирічної дівчинки на 5-й день захворювання на ГРВІ виникли багаторазове блювання, втрата свідомості. Із анамнезу відомо, що мати неконтрольовано давала дитині ацетилсаліцилову кислоту та метамізол натрію. Об'єктивно спостерігається: за шкалою ком Плазго — 5-6 балів, геморагічний синдром, гепатомегалія, АТ — 100/60 мм рт. ст. В аналізі крові виявлено: гіпоглікемія, рівні білірубину та креатиніну в нормі, гіперамоніємія, підвищення рівнів АЛАТ та АсАТ у 10 разів, зниження протромбінового індексу та рівня альбуміну. Який невідкладний стан виник у дитини?

- A. Гостра надниркова недостатність
- B. Гостра ниркова недостатність
- C. Анафілактичний шок
- D. Гостра печінкова недостатність
- E. Кетоацидотична кома

73. Пацієнт скаржиться на болючу припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання та головний біль. Об'єктивно спостерігається: у ділянці підборіддя гостро запалений щільний вузол конусоподібної форми. Шкіра над ним напружена, червона. Усередині вузла є виразка з прямовисними краями і некротичним стрижнем брудно-зеленого кольору. Підпечелюшні лімфатичні вузли праворуч збільшені і болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульоз
- B. Глибока трихофітія
- C. Третинний сифіліс
- D. Карбункул
- E. Фурункул

74. Передчасно народженому хлопчику (тер-

мін гестації — 32 тижні) з дихальними розладами та диспенсичним синдромом встановлено діагноз: гемодинамічно значуща відкрита артеріальна протока. Який лікарський засіб із нижченаведених використовують для консервативного закриття відкритої артеріальної протоки?

- A. Простагландин E
- B. Вітамін K
- C. Парацетамол
- D. Кофеїну цитрат
- E. Епінефрин

75. Пацієнта віком 52 роки госпіталізовано зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, втрату свідомості, схуднення, відсутність апетиту, нудоту та блювання, різкий біль в епігастральній ділянці, діарею та посилену пігментацію шкіри. АТ — 90/60 мм рт. ст. Який найімовірніший діагноз?

- A. Аддисонічна криза
- B. Системна склеродермія
- C. Пелагра
- D. Гострий гастроентерит
- E. Менінгоенцефаліт

76. У доношеної новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явився петехіальний висип на шкірі тулуба і обличчя, гематурія, мелена. Загальний стан не порушений. З анамнезу відомо, що вагітність і пологи у матері перебігали без ускладнень. За результатами аналізу крові виявлено: подовжений протромбіновий час і час часткової активації тромбoplastину, знижена активність II, VII, IX, X факторів згортання крові. Який найімовірніший діагноз?

- A. Геморагічна хвороба новонароджених
- B. Гемолітична хвороба новонароджених
- C. ДВЗ-синдром
- D. Гіпопластична анемія
- E. Гемофілія A

77. Проведено дослідження щодо визначення факторів ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи серед населення. У дослідженні взяло участь 4409 дорослих громадян у віці 18-69 років. У процесі вибіркового дослідження проводилось анкетування з використанням стандартних опитувальників, визначався індекс маси тіла та біохімічні параметри. Який вид дослідження використовується в цьому разі?

- A. Поточний
- B. Лонгітюдний
- C. Аналітичний
- D. Кроссекційний
- E. Вибірковий

78. Пацієнт віком 27 років скаржиться на озноб, нестерпний головний біль, біль у м'язах та під час руху очима, світлочутливість, різку слабкість. Об'єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки гіперемовані, гарячі та вологі на дотик, язик сухий, обкладений білим нальотом, температура тіла — 39,8°C, на шкірі бічних поверхонь ту-

луба, під пахвами, на спині та кінцівках візуалізується розеольозно-петехіальний висип, ЧСС — 98/хв, АТ — 130/70 мм рт. ст., печінка і селезінка помірно збільшені, безболісні під час пальпації. Позитивні симптоми Кіарі, Розенберга, Говорова-Гудельє. Аускультативно: вислуховуються поодинокі сухі хрипи над легенями, тони серця послаблені. Який найімовірніший діагноз?

- А. Лептоспіроз
- В. Висипний тиф
- С. Малярія
- Д. Грип
- Е. Черевний тиф

79. У дворічної дитини спостерігаються такі симптоми: біль у животі, метеоризм, збільшення живота, розлади випорожнень у вигляді закрелів і діареї, поліфекалія та жирний пінистий кал, зниження апетиту, млявість, недостатній набір маси тіла. Із анамнезу відомо, що стан дитини погіршується після введення в раціон харчування продуктів, виготовлених із пшениці, ячменю, жита (хлібо-булочки та макаронні вироби, крупи). За результатами копрологічного дослідження виявлено: стеаторея II типу. Який найімовірніший діагноз?

- А. Синдром Жильбера
- В. Хронічний панкреатит
- С. Муковісцидоз
- Д. Целіакія
- Е. Лактазна недостатність

80. Пацієнтка віком 39 років хворіє протягом 15 років. Під час обстеження повідомляє, що її мозком вже давно заволоділи «злочинні вчені-фізики», які випробовують на ній різні типи психотропної зброї. Відчуває на собі вплив лазерних променів, постійно чує повідомлення, які передаються їй безпосередньо в мозок. Емоційно монотонна, періодично робить якісь записи, які нікому не показує. Свідомість ясна, формальних інтелектуально-мнестичних порушень не виявлено. Який найімовірніший діагноз?

- А. Шизо-афективний психоз
- В. Параноїдна психоз
- С. Хронічний маячний розлад
- Д. Інволюційний параноїд
- Е. Реактивний параноїд

81. Пацієнт віком 55 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, парастезії пальців рук і ніг, хиткість під час ходьби. Із анамнезу відомо, що він довгий час вживає спиртні напої. Об'єктивно спостерігається: іктеричність шкіри, одутість обличчя, набряк нижніх кінцівок, гепатомегалія. В аналізі крові: гемоглобін — 92 г/л, еритроцити — $2,2 \cdot 10^{12}/л$, КП — 1,25, загальний білірубін — 28 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Постгеморагічна анемія
- В. Залізодефіцитна анемія
- С. Синдром Жильбера
- Д. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія
- Е. Гострий лейкоз

82. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C, кашель із невеликою кількістю мокротиння, утруднений вдих. Захворіла після переохолодження 2 доби тому. Під час рентгенологічного дослідження спостерігається: локальне затемнення у нижній частці правої легені. За результатами загального аналізу крові виявлено: лейкоцити — $14 \cdot 10^9/л$, ШОЕ — 44 мм/год, СРБ — 140 мг/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Спонтанний пневмоторакс
- В. Бронхіальна астма
- С. Пневмонія
- Д. Гострий бронхіт
- Е. Туберкульоз

83. У жінки віком 25 років після пологів посилилися хиткість під час ходьби та слабкість у ногах. Хворіє протягом 6-ти років, зазначає погіршення стану щороку восени. Об'єктивно спостерігається: жінка ейфорична, знижена критичність до свого стану, горизонтальний ністагм, високі сухожилкові рефлекс, клонус стоп, патологічні стопні рефлекс, черевні рефлекс відсутні, атаксія при пробі Ромберга, інтенційний тремор і промахування під час виконання координаційних проб. На очному дні спостерігається темпоральне зблидження дисків зорових нервів. Який найімовірніший діагноз?

- А. Міастенія гравіс
- В. Бічний аміотрофічний склероз
- С. Розсіяний склероз
- Д. Дисциркуляторна енцефалопатія
- Е. Гострий розсіяний енцефаломієліт

84. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на слабкість, швидку стомлюваність, біль та набряклість у суглобах. Із анамнезу відомо, що скарги виникли після відпочинку на морі, через 2 тижні підвищилася температура тіла до 38°C та виникла стійка гіперемія обличчя з елементами еритематозного висипу. У загальному аналізі крові: анемія, лейкопенія, лімфопенія, тромбоцитопенія. В аналізі сечі: протеїнурія. Який найімовірніший діагноз?

- А. Атопічний дерматит
- В. Ревматоїдний артрит
- С. Реактивний артрит
- Д. Гострий лейкоз
- Е. Системний червоний вовчак

85. Під час пологів у терміні вагітності 40 тижнів народився хлопчик. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, м'язовий тонус значно знижений, приблизна маса тіла — 3500 г. Після проведення санації верхніх дихальних шляхів та штучної вентиляції легень упродовж 30 с виявлено, що ЧСС — 40/хв. Яка подальша невідкладна допомога новонародженому в цьому разі?

- А. Непрямий масаж серця
- В. Внутрішньовенне введення епінефрину
- С. Продовжити лише штучну вентиляцію легень
- Д. Електрична дефібриляція
- Е. Киснева допомога вільним потоком

86. Пацієнт віком 44 роки скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, задишку, кашель із виділенням значної кількості гнійного мокротиння. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри, ЧСС — 116/хв, температура тіла — 39,8°C, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, притуплення перкуторного звуку та ослаблення дихання з правого боку. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: гомогенне затемнення правої половини грудної клітки. Який найімовірніший діагноз?

- А. Бронхоектатична хвороба
- В. Правобічний ексудативний плеврит
- С. Абсцес правої легені
- Д. Правобічний пневмоторакс
- Е. Емпієма плеври

87. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на різкий біль у горлі ліворуч, що іррадіює в ліве вухо, неможливість відкрити рот, підвищення температури тіла до 38,8°C. Об'єктивно спостерігається: виражений тризм жувальних м'язів, асиметрія зів, лівий піднебінний мигдалик гіперемований, зміщений до середини зів, язичок зміщений праворуч, гіперемія, інфільтрація, набряклість лівої половини м'якого піднебіння, неприємний запах із рота, підвищена саливація, зацеленні лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, болючі під час пальпації. За результатами риноскопічного та отоскопічного обстеження: без патології. Який найімовірніший діагноз?

- А. Пухлина лівого піднебінного мигдалика
- В. Пухлина правого піднебінного мигдалика
- С. Правобічний парафарингеальний абсцес
- Д. Парадонтит другого моляра
- Е. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

88. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано на 8-й день хвороби. Захворів поступово, турбують виражена загальна слабкість, помірний головний біль, безсоння, відсутність апетиту, закріп, підвищення температури тіла до 39,2°C. Об'єктивно спостерігається: стан середнього ступеня тяжкості, пульс — 60/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., ЧД — 17/хв, периферичні лімфатичні вузли не збільшені, слизова оболонка ротоглотки рожева, язик обкладений, з відбитками зубів по краю, шкіряні покриви бліді, на шкірі живота поодинокі рожеві, живіт здутий, не болючий, гепатоспленомегалія. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найімовірніший діагноз?

- А. Грип
- В. Харчова токсикоінфекція
- С. Малярія
- Д. Черевний тиф
- Е. Висипний тиф

89. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися охриплість голосу та шумний вдих. Під час плачу спостерігаються: западання над- і підключичних ямок, наростання інспіраторної задишки, які в спокої у дитини зникають. Який найімовірніший діагноз?

- А. Стороннє тіло в дихальних шляхах
- В. Пневмонія
- С. Гострий плеврит
- Д. Гострий обструктивний бронхіт
- Е. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

90. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві групи людей: учасники першої групи мають в анамнезі рак легень, учасники другої — ні. Після цього з'ясовують, хто з учасників зазнав впливу фактору, а хто ні. Потім розраховують необхідні статистичні показники та роблять висновки про вплив фактора на результат. Дизайн якого дослідження описано?

- А. Опис серії випадків
- В. Екологічне
- С. Когортне
- Д. Клінічний експеримент
- Е. Випадок-контроль

91. Пацієнт віком 17 років скаржиться на головний біль, біль у горлі та підвищення температури тіла. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно виявлено: стан тяжкий, температура тіла — 38°C. Слизова ротоглотки помірно гіперемована, набрякла, спостерігаються плівчасті нашарування на мигдаликах, піднебінні, язичку, що важко знімаються. Під час пальпації встановлено: підцеленні лімфатичні вузли збільшені, підшкірна клітковина на шиї набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий лімфобластний лейкоз
- В. Інфекційний монунокліоз
- С. Паратонзиллярний абсцес
- Д. Дифтерія
- Е. Туляремія

92. У пацієнта віком 42 роки виявлено захворювання легень. З анамнезу відомо, що працює на підприємстві, у повітрі робочої зони якого концентрація діоксиду кремнію перевищує ГДК утричі. Яке професійне захворювання, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- А. Силікатоз
- В. Антракоз
- С. Силікоз
- Д. Алюмініоз
- Е. Сидероз

93. У дівчинки на 7-му добу після народження підвищилася температура тіла до 38°C, з'явився рясний везикульозний висип по всьому

тілу та на слизових оболонках рота й піхви. З крові та вмісту везикули була виділена ДНК *Varicella-Zoster virus*. Який лікарський засіб необхідно застосувати для етіотропного лікування дитини в цьому разі?

- A. Метронідазол
- B. Ацикловір
- C. Доксикілін
- D. Озельтамівір
- E. Рибавірин

94. У пацієнта віком 35 років виник напад, під час якого з'явилися серцебиття, озноб і страх смерті. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та підвищення АТ. Напад закінчився виділенням великої кількості сечі. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Симпато-адреналовий криз
- B. Тиреотоксичний криз
- C. Колапс
- D. Епілентичний напад
- E. Гіперглікемічна кома

95. Пацієнт віком 19 років скаржиться на набряки гомілок, обличчя, помірний біль у попереку, підвищення АТ до 180/100 мм рт. ст. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому перехворів на гострий тонзиліт. У загальному аналізі сечі: протеїнурія — 1,2 г/добу, еритроцити покривають усе поле зору, еритроцитарні циліндри — 5-7 у полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний гломерулонефрит
- B. Хронічний пієлонефрит
- C. Сечокам'яна хвороба
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гострий гломерулонефрит

96. Пацієнт віком 59 років скаржиться на біль у лівому оці та лівій половині голови, значне зниження зору лівого ока, нудоту та блювання. За результатами офтальмоскопічного обстеження виявлено: гострота зору правого ока — 1,0, лівого ока — 0,03, з корекцією не поліпшується, ВОО правого ока — 21 мм рт. ст., лівого ока — 65 мм рт. ст., у лівому оці — застійна ін'єкція, рогівка набрякла, потовщена, передня камера дрібна, зіниця розширена, на світло не реагує, очне дно не видно. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий іридоцикліт лівого ока
- B. Гострий напад глаукоми лівого ока
- C. Панофтальміт лівого ока
- D. Внутрішньоочна пухлина правого ока
- E. Ендофтальміт правого ока

97. Пацієнт віком 75 років скаржиться на часте сечовипускання (4-5 разів за ніч), стоншення струменя сечі. Під час пальаторного дослідження передміхурової залози виявлено: розмір — 4х6 см, туго-еластичної консистенції, з чіткими контурами, гладенька. Результати урофлоуметрії — 42 мл/с. Під час УЗД спостерігається: у просвіті сечового міхура додаткове утворення з чіткими контурами. Залишкової сечі — 100 мл. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рак сечового міхура
- B. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози
- C. Рак простати
- D. Склероз простати
- E. Хронічний простатит

98. Пацієнтка віком 32 роки з приводу негоспітальної пневмонії приймає цефотаксим. На 5-й день лікування з'явилися водянисті випорожнення до 8-10 разів на добу, іноді з домішками свіжої крові в калі, спазматичний біль у нижніх квадрантах живота, здуття і бурчання в животі, підвищення температури тіла до 38,3°C. Який збудник, найімовірніше, спричинив погіршення стану пацієнтки?

- A. *Shigella flexneri*
- B. *Entamoeba histolytica*
- C. *Salmonella enterica*
- D. *Enterobacter aerogenes*
- E. *Clostridioides difficile*

99. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на головний біль, пудоту, блювання, загальну слабкість, набряклість обличчя, м'язову слабкість, ніктурію. В анамнезі: ІХС, СН, хронічний пієлонефрит, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння. Об'єктивно спостерігається: шкіра світло-коричневого кольору, суха, холодна, АТ — 160/90 мм рт. ст., ЧСС — 72/хв, температура тіла — 36,2°C, дихання вільне, везикулярне, живіт м'який, безболісний. Симптом Пастернацького негативний. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, сегмент ST у всіх відведеннях на ізолінії, ЕВС зміщена ліворуч. В аналізі крові: гемоглобін — 94 г/л, еритроцити — $3 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити — $5 \cdot 10^9/л$, тромбоцити — $210 \cdot 10^9/л$. В аналізі сечі: відносна густина — 1,005, еритроцити — відсутні, лейкоцити — 1 у полі зору, білок — 0,8 г/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Синдром Гудпасчера
- B. Хронічна ниркова недостатність
- C. Загострення хронічного пієлонефриту
- D. Хронічна ниркова недостатність
- E. Сечокам'яна хвороба

100. У п'ятиденної дитини кожне сечовипускання залишає на підгузках плями червоно-коричневого кольору. Зібрана сеча виявилася каламутною з осадом. В аналізі сечі: білка немає, лейкоцити — 2-3 в полі зору, еритроцити — 0-1 в полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий гломерулонефрит
- B. Гострий пієлонефрит
- C. Гострий цистит
- D. Сечокислий інфаркт
- E. Пухлина нирок

101. Пацієнту віком 44 роки встановлено діагноз: негоспітальна пневмонія. На 5-й день перебування в стаціонарі стан пацієнта погіршився: збільшилася кількість мокротиння, воно стало гнійним, температура тіла підвищилася до 40°C. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: у правій легені —

порожнина з горизонтальним рівнем рідини. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Інфаркт-пневмонія
- B. Абсцес легені
- C. Гангрена легені
- D. Бронхоекстатична хвороба
- E. Ексудативний плеврит

102. Шестирічна дитина скаржиться на підвищену температуру тіла, головний біль і біль під час ковтання. Об'єктивно спостерігається: яскраво-червоний дрібно-крапчастий висип на гіперемованій шкірі, рясніший на боковій поверхні тулуба та в природних складках, відмежована гіперемія слизової оболонки ротоглотки, гнійний наліт на мигдаликах. Який найімовірніший діагноз?

- A. Краснуха
- B. Інфекційний моновірусоз
- C. Дифтерія
- D. Скарлатина
- E. Кір

103. Пацієнт віком 50 років скаржиться на кашель із виділенням мокротиння зеленуватого кольору до 200 мл на добу, експираторну задишку під час ходьби. Із анамнезу відомо, що симптоми турбують довгий час. Об'єктивно спостерігається: акроціаноз, грудна клітка діжкоподібна, нігті нагадують годинникові скельця. Перкуторно: над проекцією всіх легеневих полів — коробковий звук, аускультативно — дихання ослаблене, розсіяні сухі різнометрові хрипи та великопухирчасті вологі хрипи у нижніх відділах легень. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: деформація та посилення легеневого малюнка, тонкостінні кільцеподібні тіні. За результатами КТ ОГК: симптом «перся», симптом «трамвайної рейки». Який найімовірніший діагноз?

- A. Кавернозна форма туберкульозу легень
- B. Абсцес легень
- C. Бронхоекстатична хвороба
- D. Ехінококоз легень
- E. Інфільтративна форма туберкульозу легень

104. Унаслідок ДТП 11 пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Під час рятувальних робіт виявлено, що в одного із постраждалих з відкритої рани плеча витікає кров яскраво-червоного кольору. Частота дихання 6 за хвилину, реагує на біль, пульс на периферійних судинах не визначається. До якої сортувальної групи за ознаками здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах належить потерпілий?

- A. Червоної
- B. Зеленої
- C. —
- D. Жовтої
- E. Чорної

105. Особливого значення в безпечній систе-

мі поводження відходами ЗОЗ займають матеріали забруднення біологічними речовинами (в т.ч. кров'ю, виділеннями пацієнтів), органічні операційні відходи та патологоанатомічні відходи. До якого класу вони належать?

- A. D
- B. A
- C. B
- D. C
- E. —

106. Пацієнтка віком 75 років скаржиться на наявність пухлини в правій грудній залозі. Під час пальпації у лівій грудній залозі патології не виявлено. У правій визначається горбисте щільне безболісне утворення, що не зміщується. Шкіра над ним має вигляд «лимонної кірки». Сосок втягнутий. Пахвові, під- і надключичні лімфатичні вузли не пальпуються. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся у правій грудній залозі?

- A. Злоякісне новоутворення
- B. Солітарна кіста
- C. Дифузна кістозна мастопатія
- D. Туберкульоз
- E. Фібroadенома

107. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38,4°C, біль у попереку. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися після переохолодження. Об'єктивно спостерігається: ЧСС — 90/хв, АТ — 115/90 мм рт. ст. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків. В аналізі крові: лейкоцити — $10,6 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоцити — $150 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ — 31 мм/год. В аналізі сечі: білок — 0,64 г/л, еритроцити змінені — 4-6 в полі зору, лейкоцити — густо покривають все поле зору, багато бактерій. Який найімовірніший діагноз?

- A. Геморагічний васкуліт
- B. Сечокам'яна хвороба
- C. Системний червоний вовчак
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гострий гломерулонефрит

108. Пацієнтку віком 58 років шпиталізовано зі скаргами на виражену задишку, що виникла день тому. В анамнезі: лімфогранулематоз. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, АТ — 106/60 мм рт. ст., під час вдиху визначається падіння систолічного АТ на 20 мм рт. ст., ЧСС — 110/хв, SpO_2 — 84%, яремні вени розширені. Аускультативно: тони серця приглушені, над легенями дихання везикулярне, хрипів немає. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: виражена кардіомегалія. Який патологічний стан призвів до погіршення стану пацієнтки?

- A. Спонтанний пневмоторакс
- B. Інфаркт міокарда
- C. Емболія легеневої артерії
- D. Тампонада серця
- E. набряк легень

109. Пацієнту віком 33 роки встановлено діагноз: вперше діагностований інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені у фазі розпаду і обсіювання, МБТ(+). Укажіть оптимальну схему хіміотерапії на першому етапі лікування в цьому разі.

- A.** Ізоніазид + піразинамід + етамбутол + левофлоксацин
- B.** Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол + канаміцин
- C.** Ізоніазид + рифампіцин + етамбутол
- D.** Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол
- E.** Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + стрептоміцин

110. У місячного хлопчика спостерігаються такі симптоми: періодичне збудження, зригання після кожного годування малими порціями молока, вищорощення нормальні за складом та об'ємом. Об'єктивно спостерігається: окружність голови — 37 см, розміри великого тім'ячка — 2,0x2,0 см, м'язовий тонус у нормі. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Пілороспазм
- B.** Краніостеноз
- C.** Макроцефалія
- D.** Пілоростеноз
- E.** Мікроцефалія

111. Пацієнт віком 32 роки, дивлячись на малюнок на шпалерах, бачить, як лінії починають рухатися, утворюючи силуети химерних тварин. Замість люстри, що висить на стелі, бачить гігантського восьминога. Встановіть психопатологічний симптом.

- A.** Псевдогалюцинації
- B.** Функціональні галюцинації
- C.** Зорові галюцинації
- D.** Парейдолічні ілюзії
- E.** Дерезалізація

112. У пацієнтки віком 28 років на 14-й день 28-денного менструального циклу з'явився різкий біль унизу живота праворуч, із запамороченням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки бліді, пульс — 100/хв, АТ — 100/70 мм рт. ст. Під час бімануального дослідження виявлено: склепіння нависають, правий яєчник збільшений до 3x5 см, пастозний, болісний під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Апоплексія правого яєчника
- B.** Гострий апендицит
- C.** Аномальна маткова кровотеча
- D.** Порушена правостороння трубна вагітність
- E.** Перекрут ніжки кісти правого яєчника

113. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, сонливість, зниження працездатності, запаморочення, утруднення ковтання їжі, сухість шкіри та випадіння волосся, ламкість нігтів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді, нігті ламкі, поперечно посмуговані. Дефіцит якого нутрієнта зумовив

виникнення цього стану в жінки?

- A.** Заліза
- B.** Вітаміну B₆
- C.** Фосфору
- D.** Вітаміну D
- E.** Калію

114. Пацієнт віком 20 років скаржиться на головний біль, похолодання та біль у нижніх кінцівках. Об'єктивно спостерігається: добре розвинені м'язи плечового поясу, верхівковий поштовх та ліва межа відносної тупості зміщені назовні. Аускультативно: акцент другого тону серця над аортою, систолічний шум по лівому краю груднини. АТ на обох верхніх кінцівках — 150/80 мм рт. ст., у підколінній ямці праворуч та ліворуч — 100/70 мм рт. ст. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка серця. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Аортальна недостатність
- B.** Гіпертонічна хвороба
- C.** Коарктація аорти
- D.** Аортальний стеноз
- E.** Хвороба Такайсу

115. У військового під час бою з'явився стан знерухомлення, мутизм, вербальний контакт із ним неможливий, за тактильного контакту афект страху посилюється. Об'єктивно спостерігається: на обличчі вираз страху, не рухається, погляд фіксований в одній точці, на питання не відповідає. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Іпохондричний розлад
- B.** Посттравматичний стресовий розлад
- C.** Гострий реактивний ступор
- D.** Соматизований розлад
- E.** Депресивний розлад

116. Пацієнтку віком 32 роки шпиталізовано зі скаргами на напад болю у правому підбер'ї з іррадіацією в спину, нудоту, повторне блювання без полегшення стану. Із анамнезу відомо, що ці скарги з'явилися вперше 2 дні тому. За результатами УЗД ОЧП виявлено: в ділянці тіла біля шийки жовчного міхура візуалізуються 2 плаваючі конкременти діаметром 6 і 8 мм відповідно, жовчний міхур середніх розмірів, його стінки не потовщені. Після консервативного лікування вказані симптоми регресували, загальний стан нормалізувався, пацієнтка відмовилася від пропозиції планової холецистектомії, хоче спробувати нехірургічне лікування. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для медикаментозного розчинення каменів у біліарній системі?

- A.** Алопуринол
- B.** Транексамова кислота
- C.** Урсодезоксихолева кислота
- D.** Ціанокобаламін
- E.** Домперидон

117. Жінка віком 34 роки, в терміні вагітності 32 тижні, скаржиться на біль у ділянці епігастрію. Об'єктивно спостерігається: АТ — 160/90 мм рт. ст., пульс — 102/хв, матка в

нормотонусі, серцебиття плода звучне, ритмічне, 164/хв. В аналізі крові: гемоглобін — 86 г/л, еритроцити — $2,8 \cdot 10^{12}$ /л, тромбоцити — $80 \cdot 10^9$ /л, креатинін — 120 мкмоль/л, білірубін — 32 мкмоль/л, АлАТ — 225 Од/л, АсАТ — 215 Од/л. В аналізі сечі: колір — темний, уробілін — 32 мкмоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Тяжка прееклампсія
- В. Помірна прееклампсія
- С. Гестродуоденіт
- Д. Анемія вагітних
- Е. HELLP-синдром

118. У дворічної дитини спостерігаються вздуття живота та закрепи. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися в дев'ятимісячному віці. Під час іригографії виявлено: звужена зона у дистальних відділах товстої кишки з воронкоподібним переходом у супрастенотичне розширення. Який найімовірніший діагноз?

- А. Доліхосигма
- В. Хвороба Гіршпрунга
- С. Дивертикул Меккеля
- Д. Подвоєння кишечника
- Е. Хвороба Крона

119. Пацієнт віком 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття важкості та розпирання в епігастральній ділянці після прийому їжі, блювання 1 раз на 2-3 дні залишками їжі, вживаною напередодні, втрату маси тіла — близько 10 кг за останні 2 місяці. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на виразкову хворобу шлунка протягом 5 років. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у пацієнта?

- А. Діафрагмальна грижа
- В. Дуоденогастральний рефлюкс
- С. Перфорація
- Д. Пенетрація
- Е. Стеноз воротаря шлунка

120. У дівчинки віком 14 років раптово розвинувся напад серцебиття, який супроводжувався запамороченням, нудотою, відчуттям страху. Об'єктивно спостерігається: тахікардія — 220-230/хв без ознак застійної серцевої недостатності. На ЕКГ: ЧСС — 190-230/хв, зубці Р реєструються перед комплексом QRS, комплекси QRS нормальні, вузькі. Встановлено попередній діагноз: пароксизмальна надшлуночкова тахікардія. Проведені вагусні проби не дали позитивного ефекту. Який наступний крок у наданні медичної допомоги буде найбільш доцільним у цьому разі?

- А. Внутрішньовенне введення аденозину
- В. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- С. Внутрішньовенне введення аміодарону
- Д. Пероральне застосування нітрогліцерину
- Е. Пероральне застосування біспрололу

121. Батьки десятирічного хлопчика звернули увагу на загальну слабкість дитини, швидку стомлюваність, дратівливість, зниження

працездатності, успішності у навчанні, небажання займатися спортом, часті застудні захворювання, кровоточивість ясен під час чищення зубів, синці на ногах і руках. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану дитини?

- А. Аскорбінової кислоти
- В. Ергокальциферолу
- С. Рибофлавіну
- Д. Тіаміну
- Е. Ретинолу

122. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на головний біль, слабкість, підвищену температуру тіла та біль у горлі. Об'єктивно спостерігається: помірна гіперемія слизової оболонки зів, збільшені мигдалики та всі групи лімфатичних вузлів, 1-3 см у діаметрі, щільні, еластичні, малоболісні та не спаяні між собою. Гепатоспленомегалія. За результатами аналізу крові виявлено: лейкоцитоз, лімфоцитоз, віроцити — 15%. Який найімовірніший діагноз?

- А. Інфекційний мононуклеоз
- В. Скарлатина
- С. Гострий лімфобластний лейкоз
- Д. Дифтерія
- Е. Аденовірусна інфекція

123. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на появу висипу в ділянці аксиллярних западин. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти днів. Об'єктивно спостерігається: в ділянці аксиллярних западин відзначається наявність болючих вузлів (по три з обох боків), м'якої консистенції, величиною з вишню із почервонінням шкіри в уражених місцях, з лівого боку два вузли перфоровані з утворенням отвору з наявністю гною, з правого боку — вузли зливаються між собою. Під час пальпації болісність в ділянці вузлів, загальна температура тіла підвищена до 37,5°C. Який найімовірніший діагноз?

- А. Еритразма
- В. Псоріаз
- С. Гідраденіт
- Д. Фурункульоз
- Е. Гумозні сифіліди

124. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на значні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, печію, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів протягом 3-х днів. Із анамнезу відомо, що ці симптоми з'явилися після незахищеного статевого акту. Під час піхвового дослідження виявлено: слизова оболонка піхви гіперемована, виділення значні, жовто-зелені, пінисті. Який найімовірніший діагноз?

- А. Бактеріальний вагіноз
- В. Трихомонадний кольпіт
- С. Мікоплазмоз
- Д. Хламідіоз
- Е. Кандидозний кольпіт

125. Пацієнт віком 55 років скаржиться на головний біль, запаморочення, свербіж

біж шкіри та кровоточивість із ясен. Об'єктивно спостерігається: шкіра з червоноціанотичним відтінком, спленомегалія. За результатами загального аналізу крові виявлено: еритроцити — $7,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін — 206 г/л, КП — 0,95, лейкоцити — $10,3 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ — 2 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- В. Гострий мієлоїдний лейкоз
- С. Лімфогранулематоз
- Д. Еритремія
- Е. Множинна мієлома

126. Медичний працівник загальноосвітньої школи на підставі довідки про стан здоров'я здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. До якої групи належить учень 5 класу, який знаходиться в реабілітаційному періоді після гострого бронхіту, що не потребує курсу лікувальної фізкультури із середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи (індекс Руф'є — 7)?

- А. Додаткової
- В. Підготовчої
- С. Спеціальної
- Д. Основної
- Е. Ізольованої

127. Пацієнтка віком 62 роки звернулася до лікаря на 4-й день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, наявність яскраво-рожевої плями на шкірі лівої гомілки діаметром 10х7 см, з чіткими межами, біль у суглобах, постійний головний біль, зниження апетиту, нудоту. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — $38,5^{\circ}\text{C}$, АТ — 130/70 мм рт. ст., пульс — 68/хв, свідомість збережена, позитивні менингеальні симптоми, ністагм, знижені черевні рефлексі. За два тижні до появи скарг відпочивала на дачі, помітила і самостійно зняла із себе кліща, по медичну допомогу не зверталася. Який найімовірніший діагноз?

- А. Ентеровірусна інфекція
- В. Бешіа
- С. Хвороба Лайма
- Д. Сибірка
- Е. Кліщовий енцефаліт

128. Пацієнт віком 58 років скаржиться на дискомфорт та часті позиви до сечовипускання, біль у промежині з іррадіацією в калитку, підвищення температури тіла до $38,4^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися через 1 добу після переохолодження. Трисклянковий аналіз сечі: I порція (білок — 0,33 г/л, лейкоцити — 50-60 в полі зору, еритроцити — 8-12 в полі зору), II порція (білок — сліди, лейкоцити — 10-12 в полі зору, еритроцити — 1-3 в полі зору), III порція (білок — сліди, лейкоцити — 12-14 в полі зору, еритроцити — 3-5 в полі зору, білок — сліди). За результатами УЗД: розмір пирки — 104 мм, чашково-мискова система не розширена, каменів немає, паренхіма нирок — 15

мм, сечовий міхур — стінка 3 мм, каменів не виявлено, об'єм передміхурової залози — 56 см³, гідрофільна. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий простатит
- В. Гострий гломерулонефрит
- С. Сечокам'яна хвороба
- Д. Гострий пієлонефрит
- Е. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

129. У чотирирічного хлопчика протягом 2-х днів спостерігаються такі симптоми: на тулубі, розгинальних поверхнях кінцівок — яскравий дрібно-плямистий висип на незміненому фоні шкіри без тенденції до злиття, збільшені потиличні та задньо-шийні лімфатичні вузли, температура тіла — 38°C . Із анамнезу відомо, що хлопчик не вакцинований. Який найімовірніший діагноз?

- А. Вітряна віспа
- В. Скарлатина
- С. Краснуха
- Д. Кір
- Е. Інфекційний мононуклеоз

130. У пацієнтки віком 38 років спостерігається нападоподібне підвищення артеріального тиску до 235/120 мм рт. ст. Під час нападу пацієнтка скаржиться на нудоту, блювання, тахікардію, пітливість, страх смерті, головний біль, задишку, тремор рук і блідість шкіри. Напади починаються раптово та тривають 20-40 хв. У крові під час нападу спостерігається: лейкоцитоз з еозинофілією, глюкоза крові — 6,3 ммоль/л. Напад закінчується поліурією, після чого пацієнтка відзначає сонливість, почервоніння шкіри, тривалий час зберігається загальна слабкість. Який найімовірніший діагноз?

- А. Феохромоцитома
- В. Первинний гіперальдостеронізм
- С. Хвороба Іценко-Кушинга
- Д. Гіпертиреоз
- Е. Цукровий діабет

131. Пацієнт із вивихом плеча скаржиться на відчуття оніміння в пальцях кисті. Об'єктивно спостерігається: обмежене активне відведення I пальця. Який нерв пошкоджено в пацієнта?

- А. Шкірний
- В. Променевий
- С. Серединний
- Д. Плечовий
- Е. Ліктьовий

132. У пацієнта віком 55 років за результатами рентгенографії ОГК виявлено: поодинокі вогнища малої інтенсивності зливного характеру на верхівці правої легені. В анамнезі: резекція шлунка з приводу виразкової хвороби, курить протягом 15-ти років. Скарг пацієнт не має. Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не прослуховуються. Перкуторно: над легеньми — легеневиий звук. Аналіз крові без змін. Який найімовірніший

діагноз?

- A. Метастатичний рак
- B. Периферичний рак
- C. Пневмонія
- D. Вогнищевий туберкульоз
- E. Саркоїдоз

133. Вагітну жінку віком 22 роки шпиталізовано в тяжкому стані зі скаргами на появу набряків, головний біль, нудоту, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: свідомість потьмарена, АТ — 160/130 мм рт. ст., дрібні фібрилярні посмикування м'язів обличчя, утруднене носове дихання. Під час транспортування почалося посмикування верхніх кінцівок, тіло жінки витяглося, хребет вигнувся, щелепи щільно стиснулися, дихання припинилося. Після цього з'явилися клонічні судоми, виражений ціаноз. Потім судоми припинилися, з'явився глибокий шумний вдих, на губах виступила піна, забарвлена кров'ю. Який найімовірніший діагноз?

- A. Діабетична кома
- B. Еклампсія
- C. Гіпертонічний криз
- D. Епілепсія
- E. Хорея

134. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на рясні та тривалі менструації упродовж останніх 6-ти місяців. В анамнезі: пологи — 1, штучний аборт — 1. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: шийка матки без дефектів епітелію, виділення слизові помірні, тіло матки та придатки нормальних розмірів, безболісні. За результатами УЗД виявлено: товщина ендометрія — 17 мм. Який метод дослідження найінформативніший для встановлення діагнозу в цьому разі?

- A. Визначення онкомаркерів
- B. Цитологічне дослідження пайпель-аспірату з порожнини матки
- C. Гістологічне дослідження пайпель-аспірату з порожнини матки
- D. Гістероскопія
- E. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

135. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк у ділянці лівої гомілки, загальне нездужання, озноб, підвищення температури тіла до 39°C. Початок захворювання пов'язує з подряпиною шкіри лівої гомілки, який стався 2 дні тому. Об'єктивно виявлено: в середній третині лівої гомілки спостерігається яскрава гіперемія шкіри, що має чіткі межі та підвищується над незміненою шкірою. Виявлено помірний набряк м'яких тканин, їхня болючість під час пальпації, у центрі гіперемованої шкіри — струн 2x0,2 см, що покриває поверхневу ранку. Яке ускладнення мікротравми лівої гомілки спостерігається в пацієнтки?

- A. Гострий гнійний остеомієліт
- B. Газова гангрена
- C. Гострий тромбофлебіт глибоких вен
- D. Флегмона
- E. Бешиха

136. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на тривалу кровотечу зі статевих шляхів. Періодично турбують серозно-кров'яністі виділення з гнильним запахом, кровоспинні засоби не допомагають. Чотири місяці тому було проведено вишкрібання порожнини матки у зв'язку з пузирним заносом. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рак ендометрія
- B. Ендометріоз
- C. Рак шийки матки
- D. Хоріонепітеліома
- E. Лейоміома матки

137. Пацієнт віком 26 років скаржиться на висип у ділянці обличчя, свербіж, жар, біль. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом двох років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя в ділянці підборіддя — інфільтровані ділянки яскраво-червоного кольору, засіяні пустулами та кірками, з численними ерозіями, по периферії розташовані папуло-пустульозні елементи. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сикоз
- B. Контактний дерматит
- C. Звичайні вугри
- D. Короста
- E. Екзема

138. Пацієнтка віком 56 років із надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється під час ходьби, особливо сходами, під час довгого стояння на ногах. Хворіє протягом 5-ти років. Об'єктивно встановлено: колінні суглоби деформовані, набряклі, під час руху — болючі. За результатами рентгенографії колінних суглобів виявлено: суглобова щілина звужена, субхондральний склероз, краєві остеопіти. Який найімовірніший діагноз?

- A. Подагра
- B. Ревматоїдний артрит
- C. Ревматичний артрит
- D. Остеоартроз
- E. Реактивний артрит

139. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано зі скаргами на гострий біль в епігастральній ділянці. Об'єктивно спостерігається: рівень свідомості за ШКГ — 13-14 балів, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, шкіра вкрита холодним потом, температура тіла — 37,3°C, ЧСС — 120/хв, АТ — 80/40 мм рт. ст., дихання поверхневе, часте, живіт дещо здутий, під час пальпації незначно болючий, випорожнення дьогтеподібні, блювання малозміненою кров'ю. У загальному аналізі крові: гемоглобін — 90 г/л, еритроцити — $3 \cdot 10^{12}/л$. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- А. Кишкова кровотеча
- В. Перфорація кишки
- С. Пенетрація виразки шлунка
- Д. Псевдомембранозний коліт
- Е. Тромбоз мезентеріальних судин

140. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на гострий біль у правій половині живота, що іррадіює в праву надключичну ділянку, підвищення температури тіла, сухість та гіркоту в роті. Із анамнезу відомо, що було неодноразове блювання, яке не приносило полегшення, появу болю пов'язує з уживанням жирної та смаженої їжі. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці, шкірні покриви бліді, тахікардія, язик сухий, живіт під час пальпації болючий у правій половині живота та дещо напружений у правому підребер'ї. Позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який найімовірніший діагноз?

- А. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки
- В. Гострий холецистит
- С. Гострий апендицит
- Д. Гостра кишкова непрохідність
- Е. Правобічна ниркова коліка

141. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на швидку стомлюваність, виражену слабкість у проксимальних м'язів кінцівок, судомні посмикування м'язів гомілок, головний біль. Об'єктивно спостерігається: ІМТ — 27 кг/м². АТ — 180/100 мм рт. ст., пульс — 90/хв. В аналізі крові: низький рівень реніну, калій — 2,6 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Есенціальна артеріальна гіпертензія
- В. Первинний альдостеронізм
- С. Хвороба Іценко-Кушинга
- Д. Тиреотоксикоз
- Е. Феохромоцитома

142. Жінка віком 27 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя. Статевим життям живе в шлюбі 4 роки, вагітності не запобігає. За результатами обстеження жінки встановлено: розвиток статевих органів без відхилень від норми, прохідність маткових труб не порушена, базальна температура протягом 3-х менструальних циклів однофазна. Яка найімовірніша причина безпліддя в цьому разі?

- А. Імунологічне безпліддя
- В. Ановуляторний менструальний цикл
- С. Генітальний ендометріоз
- Д. Хронічний аднексит
- Е. Аномалії розвитку статевих органів

143. Пацієнт віком 45 років скаржиться на переймоподібний біль у животі, тенезми, часті рідкі випорожнення з домішками крові. Хворіє протягом 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, АТ — 110/60 мм рт. ст., пульс — 98/хв, живіт м'який, болючий під час пальпації по ходу товстої кишки. За результатами іригоскопії виявлено: товста кишка звужена, гаустри відсутні, контури нерівні, нечіткі. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити —

3,2 · 10¹²/л, гемоглобін — 110 г/л, КР — 0,85, лейкоцити — 8,1 · 10⁹/л, паличкоядерні нейтрофіли — 5%, лімфоцити — 30%, моноцити — 3%, еозинофіли — 3%, сегментоядерні нейтрофіли — 59%, ШОЕ — 24 мм/год. Фекальний кальпротектин — 95 Од. Який лікарський засіб необхідно призначити першочергово в цьому разі?

- А. Ципрофлоксацин
- В. Лоперамід
- С. Месалазин
- Д. Панкреатин
- Е. Дротаверин

144. Пацієнта віком 60 років ппшталізовано без свідомості. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію, приймає інсулін і гіпотензивні засоби. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкіра суха, тургор знижений, язик сухий, обкладений коричневим нальотом, тонус м'язів і очних яблук знижений, температура тіла — 38,2°C, пульс слабого наповнення — 108/хв. Аускультативно — тони серця глухі. АТ — 90/50 мм рт. ст., дихання часте, поверхневе. Запах ацетону відсутній. В аналізі крові: глюкоза — 58 ммоль/л, загальний білок — 105 г/л, сечовина — 16 ммоль/л, натрій — 238 ммоль/л, калій — 5,5 ммоль/л, молочна кислота — 0,8 ммоль/л. В аналізі сечі: глюкоза — 15 ммоль/л, кетонів тіла відсутні. Який вид коми, найімовірніше, виник у пацієнта?

- А. Печінкова
- В. Кетоацидотична
- С. Уремична
- Д. Молочнокисла
- Е. Гіперосмолярна

145. Серед усіх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується поліклінікою міста, пацієнти з цукровим діабетом становлять 21%. Який статистичний показник наведено?

- А. Наочності
- В. Інтенсивний
- С. Співвідношення
- Д. Екстенсивний
- Е. Кореляції

146. Пацієнт віком 45 років скаржиться на гарячку, озноб, пітливість у нічний час, прискорене серцебиття, виражену слабкість протягом 2-х тижнів. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, множинні підшкірні вузлики до 3 мм на подушечках пальців рук та ніг, температура тіла — 38,5°C. Перкуторно: межі серця розширені ліворуч, аускультативно в точці Боткіна-Ерба вислуховується діастолічний шум. АТ — 110/40 мм рт. ст., ЧСС — 132/хв. Три проби посіву крові позитивні на *Staphylococcus aureus* (резистентний до метициліну). Встановлено діагноз: інфекційний ендокардит. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту в цьому разі?

- А. Рифампіцин
- В. Азтреонам
- С. Ампіцилін
- Д. Ванкоміцин
- Е. Цефтріаксон

147. Жінку віком 25 років шпиталізовано до пологового будинку зі скаргами на підтікання прозорих навколоплідних вод. Із анамнезу відомо, що вагітність перша, 27 тижнів. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний, температура тіла — $36,6^{\circ}\text{C}$, пульс — 68/хв, матка в нормальному тонусі, ВДМ — 26 см, ОЖ — 80 см, положення плода поздовжнє, серцебиття ясне, ритмічне — 138/хв. Під час огляду в дзеркала підтікають прозорі навколоплідні води. Обрана очікувальна тактика ведення вагітності. Проте через 3 доби у вагітної на тлі підвищення температури тіла до $37,3^{\circ}\text{C}$ з'явилися скарги на рясні гнилісні виділення. Тонус матки підвищений. Серцебиття плода — 168/хв. В аналізі крові: лейкоцитоз — $15 \cdot 10^9/\text{л}$. Яке ускладнення розвинулося у вагітної?

- А. Ендометріоз
- В. Хоріоамніоніт
- С. Передчасні пологи
- Д. Передчасне відшарування плаценти
- Е. Дистрес плода

148. У шестирічної дівчинки спостерігається: відставання у фізичному розвитку, напади неспритомності, задишка, блідість шкіри, розширення меж серця та систолічне дрижання в II міжребер'ї, акцент II тону над легеневою артерією та систоло-діастолічний шум у міжлопатковій ділянці. Під час рентгенографії ОГК виявлено: посилення легеневого малюнка, кардіомегалія за рахунок лівих відділів серця, випинання дуги легеневої артерії. Який найімовірніший діагноз?

- А. Відкрите овальне вікно
- В. Транспозиція магістральних судин
- С. Терада Фалло
- Д. Відкрита артеріальна протока
- Е. Стеноз отвору легеневої артерії

149. Пацієнтка віком 76 років під час спроби повернутися відчула різкий біль у ділянці лівого стегна, після чого впала на ліве стегно. Об'єктивно спостерігається: ліва стопа ротована назовні, вкорочення правої нижньої кінцівки до 1,5 см, позитивний симптом «прилиплої п'яти», рухи в лівому кульшовому суглобі обмежені, болісні, з іррадіацією у ділянку попереку. Із анамнезу відомо, що пацієнтка довгий час приймає глюкокортикостероїди. Який найімовірніший діагноз?

- А. Перелом шийки стегнової кістки
- В. Перелом ацетабулярної западини
- С. Підвертлюговий перелом стегнової кістки
- Д. Люмбопшалгія
- Е. Вивих голівки стегнової кістки

150. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано через 40 хв після ДТП. Об'єктивно спостерігається: пацієнт до вербального контакту не доступний, на біль реагує гримасою недоволення та згинанням кінцівок, очі не розплющує, звуки не промовляє, шкірні покриви ціанотичні, на лобі садно, дихання самостійне, ЧД — 12/хв, поверхневе, АТ — 150/90 мм рт. ст., ЧСС — 108/хв. Аускультативно: над легенями дихання ослаблене, вислуховується у всіх відділах, провідні хрипи, тони серця приглушені, ритмічні. Живіт м'який, безболісний. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту першочергово в цьому разі?

- А. Виконати електричну дефібриляцію
- В. Внутрішньовенно ввести 400 мл 5%-ий розчин глюкози
- С. Внутрішньовенно ввести 1 мг епінефрину
- Д. Інтубацію трахеї
- Е. Непрямий масаж серця